Uviaznutí na antihistaminikách pri CKD-aP? Čas na prehodnotenie

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Svrbenie pri CKD nevzniká histamínom – preto antihistaminikum spravidla nezaberá.

Chronické svrbenie u pacientov s chronickým obličkovým ochorením (CKD) alebo u dialyzovaných sa príliš často prehliada. A keď sa už zistí, stále sa neraz siahne po antihistaminikách ako po „prvom riešení“. V praxi však môže ísť o úplne iný mechanizmus svrbenia, takže aj dobrý úmysel skončí bez účinku.

V tomto článku vychádzam zo vzdelávacej aktivity zameranej na CKD-aP (CKD-associated pruritus, svrbenie pri CKD) a na to, prečo antihistaminiká často netrafia podstatu problému.

Prípad z praxe: silné svrbenie, ktoré nikto včas nezachytil

V dialyzačnom stredisku zachytili 62-ročného muža s polycystickým ochorením obličiek, ktorý bol približne 1 rok liečený hemodialýzou. Svrbenie bolo závažné a trvalo minimálne 3 mesiace, pričom pacient o ňom nikdy nehovoril ani zdravotníkom na vizitách.

Pri vyšetrení boli kožné lézie zjavne druhotné, typicky z následkov škrabania (exkoriácie, prurigo lézie). Po vylúčení iných príčin chronického pruritu sa potvrdilo CKD-aP. Intenzita svrbenia na škále WI-NRS bola 7/10, svrbenie výrazne znižovalo kvalitu života a sprevádzali ho nedostatok spánku, úzkosť a výrazná spoločenská izolácia. Antihistaminiká boli predtým nasadené, ale bez efektu.

Tento prípad dobre ilustruje dve veci: CKD-aP môže byť „neviditeľné“, ak sa naň nikto aktívne nepýta, a antihistaminiká nemusia zasiahnuť správnu dráhu svrbenia.[1]

Prečo antihistaminiká pri CKD-aP zvyčajne nepomáhajú

Svrbenie pri CKD-aP nie je primárne sprostredkované histamínom. Svrbiaci signál ide skôr cez nehistamínové nervové dráhy. Preto antihistaminiká síce môžu u niektorých pacientov navodiť sedáciu, ale podstatu patofyziológie CKD-aP neovplyvnia.[1]

Ďalší praktický detail: väčšina pacientov má generalizované svrbenie, nie lokálny problém. Samotné lokálne opatrenia preto pravdepodobne nepomôžu a o to viac je potrebná cielenejšia liečba.[1]

Čo dnes vieme o mechanizmoch CKD-aP

Za posledné roky sa lepšie pochopila patogenéza. V aktivite sa zdôrazňuje:

- **nehistamínová nervová signalizácia** pri CKD-aP,
- zapojenie **interleukínov**, najmä **IL-31**,
- **nerovnováha medzi mu a kappa opioidnými receptormi**, kde prevláda mu-sprostredkovaná signalizácia, ktorá svrbenie podporuje.[1]

Tieto poznatky otvorili priestor pre liečbu, ktorá namiesto zaužívaného antihistaminika cielene zasahuje príslušné dráhy.

Základ, ktorý platí vždy

Ani pri cielenej liečbe netreba podceňovať základné opatrenia. V aktivite zazneli:

1. **denné používanie emoliencií a zvlhčovanie kože** (moisturizers),
2. **adekvátna dialýza**, s cieľom **single-pool Kt/V 1,4** u hemodialyzovaných.[1]

Tieto kroky nevyriešia všetko, ale obmedzujú faktory, ktoré môžu svrbenie zhoršovať.

Difelikefalin: presun od symptomatických „skúšok“ k cielenej terapii

V rozhovore sa difelikefalin (DFK) predstavuje ako liečba s odporúčaním v európskych smerniciach pre chronický pruritus a ako štandard starostlivosti (standard of care) pri CKD-aP u hemodialyzovaných. Pôsobí na **kappa-opioidné receptory** a obnovuje rovnováhu voči mu-receptorom.[1]

Mechanizmus účinku v skratke

- DFK je **selektívny agonista kappa-opioidných receptorov** na senzorických neurónoch aj v imunitnom systéme.
- Pôsobí **periférne**, bez typických centrálnych opioidných problémov.[1]

Klinický dôkaz: KALM-1 a KALM-2

Podľa aktivity boli výsledky štúdií fázy 3 (KALM-1 a KALM-2) konzistentné. Spolu bolo hodnotených **851 účastníkov** s miernym až závažným CKD-aP. V súhrnnej analýze dosiahlo **aspoň 3-bodové zníženie WI-NRS**:

- **51 %** u pacientov liečených DFK
- vs. **35 %** v skupine placeba.[1]

Zlepšenie sa netýkalo len intenzity svrbenia, ale aj spánku a kvality života hodnotených škálami (napr. 5-D Itch a Skindex-10). Výsledky sa oddeľovali **už v 1. týždni**.[1]

Biologická stopa zápalu

Doplnkový pohľad ponúkajú zápalové markery. V aktivite sa spomína analýza 20 cirkulujúcich zápalových markerov, kde sa pri reagujúcich pacientoch po 12 týždňoch liečby pozoroval **pokles biomarkerov** (najmä IL-31, CCL2, CXCL10, TSLP a nerve growth factor), zatiaľ čo u nereagujúcich alebo v placebovej skupine nie. To podporuje hypotézu, že DFK zasahuje nielen senzorickú dráhu svrbenia, ale aj neuroimunitné mechanizmy.[1]

Bezpečnosť a obava z opioidov

V diskusii sa explicitne rieši obava z „opioidov“ v kontexte závislosti. V aktivite zaznelo, že kappa-opioidy **nie sú návykové** (neaktivujú „reward“ mechanizmus) a majú dobrý bezpečnostný profil bez typických centrálnych opioidných nežiaducich účinkov.[1]

Praktický záver: pravidelne sa pýtať, merať a liečiť cielene

Z aktivity vyplývajú dve praktické posolstvá:

1. **CKD-aP treba aktívne vyhľadávať**: podstatné je pýtať sa na svrbenie v pravidelných intervaloch (v dialýze typicky každé 3 mesiace), **merať závažnosť** a následne liečiť.
2. Ak má pacient CKD-aP, **antihistaminiká často nemajú racionálne miesto ako prvá línia**, lebo nezasahujú hlavnú cestu svrbenia. Namiesto nich treba siahnuť po liečbe cielenej na patofyziológiu.[1]

Zdroj: *Medtelligence CE na ReachMD, „Stuck on Antihistamines for Managing Patients With CKD-aP? Time to Reconsider!“ (transkript aktivity). Zdroj aktivity.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=uviaznuti-na-antihistaminikach-pri-ckd-ap-cas-na-prehodnotenie · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.